

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Guia de Precauções para o Balcão de Farmácia

Vitaminas A | D | E | K | C | B-complexo
Minerais: Iodo | Ferro | Cálcio | Magnésio | Zinco | Selénio
Omega-3 | Multivitamínicos | Plantas medicinais
Interações | Contraindicações | Populações especiais

Vitaminas

Minerais

Omega-3

Plantas

Multivitamínicos

Populações Especiais

Sílvia Pernas | Farmacêutica Especialista em Farmácia Comunitária

NextPharma Academy | [linkedin.com/in/silviapernas](https://www.linkedin.com/in/silviapernas)

1

ENQUADRAMENTO

O que são suplementos alimentares

Os suplementos alimentares são generos alimentícios destinados a complementar a alimentação normal, comercializados sob a forma de doses (cápsulas, comprimidos, saquetas). Em Portugal são regulados pelo Decreto-Lei n.º 136/2003 e pela DGAV. Ao contrário dos medicamentos, não carecem de autorização de introdução no mercado, o que não implica ausência de risco clínico: muitos apresentam interações farmacológicas significativas e risco real de toxicidade por sobredosagem.

Princípios de indicação: Suplementar só com deficiência documentada, risco aumentado de deficit ou necessidade fisiológica acrescida (gravidez, doença crónica, restrição dietética). Avaliar sempre a dieta antes do suplemento. Conhecer os UL (níveis máximos toleráveis) da EFSA. Identificar duplicações entre produtos. Verificar interações com medicação. Referenciar ao médico quando há doença crónica ou medicação regular.

2

PERGUNTAS ESSENCIAIS

Antes de qualquer indicação

1	Tem doença crónica diagnosticada? Renal, hepática, tiroideia, autoimune, oncológica: avaliar individualmente antes de indicar.
2	Toma medicação regularmente? Verificar interações. Anticoagulantes, antiepiléticos, imunossuppressores: precaução máxima.
3	Está grávida, a amamentar ou planeia engravidar? Necessidades alteradas. Alguns suplementos são teratogénicos em doses elevadas (ex. Vitamina A).
4	Já toma outro suplemento ou multivitamínico? Avaliar duplicação de nutrientes e risco de ultrapassar o nível máximo tolerável (UL).
5	Tem alergia ou intolerância conhecida? Excipientes frequentes: gluten, soja, lactose, corantes. Verificar sempre o rótulo.
6	Segue dieta restritiva (vegan, sem gluten, hipocalórica)? Aumenta o risco de multiplas deficiências. Avaliar o perfil nutricional completo.
7	Apresenta sintomas novos ou não investigados? Cansaco, palpitações, perda de peso, dores ósseas, alterações cognitivas: referenciar ao médico.
8	Ha quanto tempo toma e com que finalidade? Tomas prolongadas sem monitorização aumentam o risco de toxicidade cumulativa.

! Referenciar imediatamente ao médico se: anemia sintomática, tetania, perda de peso involuntária >5% em 3 meses, nódulos palpados, sintomas de toxicidade (náuseas, vômitos, confusão, palpitações), análises alteradas sem acompanhamento ativo, ou uso de doses muito acima das recomendadas por periodo prolongado.

3

VITAMINAS LIPOSSOLÚVEIS

A, D, E, K

Acumulam-se nos tecidos adiposos e no fígado. Risco real de toxicidade por sobredosagem, especialmente nas vitaminas A e D. Tomas prolongadas acima do UL podem causar hipervitaminose clinicamente significativa.

Vitamina	Dose ref.	UL (EFSA)	Risco principal	Nota de balcão
Vitamina A	700-900 mcg/dia	3000 mcg/dia	Teratogenica no 1.o trim. em doses >3000 UI/dia. Hepatotóxica em sobredosagem crónica. Beta-caroteno em fumadores: risco aumentado de cancer do pulmao.	Não associar a isotretinoína. Evitar doses altas na gravidez.
Vitamina D	800-2000 UI/dia	4000 UI/dia	Hipercalcemia com doses elevadas: cálculos renais, calcificações vasculares, arritmias.	Precaução em DRC, sarcoidose, hiperparatiroidismo. Monitorizar Ca e 25(OH)D.
Vitamina E	15 mg/dia	300 mg/dia	Doses altas aumentam risco hemorrágico. Potencia anticoagulante da varfarina.	Suspender 2 sem. antes de cirurgia. Precaução em anticoagulados.
Vitamina K	90-120 mcg/dia	Não estab.	Antagoniza diretamente a varfarina. Mesmo pequenas variacoes desestabilizam o INR.	Contraindicada em doentes com varfarina sem monitorização rigorosa.

4

VITAMINAS HIDROSSOLÚVEIS

C, B6, B12, Folato, Niacina

Eliminadas pela urina com menor risco de acumulação. Contudo doses elevadas de B6 e C causam toxicidade clínica real. A deficiência de B12 e folato tem implicacoes hematológicas e neurológicas graves.

Vitamina	Dose ref.	UL (EFSA)	Risco / Precaução	Nota de balcão
Vitamina C	80-110 mg/dia	2000 mg/dia	Doses altas: diarreia, cálculos de oxalato de cálcio. Interfere com testes de glicemia.	Precaução em litíase renal e hemocromatose.
Vitamina B6	1.3-1.7 mg/dia	25 mg/dia	Neuropatia periférica com doses >50 mg/dia prolongadas. Reversível após suspensão.	Frequente em suplementos 'para a mulher' em doses excessivas. Verificar rótulo.
Vitamina B12	2.4 mcg/dia	Não estab.	Sem toxicidade conhecida. Deficiencia em vegans, idosos, gastrite atrofica, utilizadores de metformina.	Idosos e vegans: monitorizar anualmente. Metformina reduz absorção.
Ácido fólico	400 mcg/dia	1000 mcg/dia	Doses altas mascaram deficiência de B12. Antagonismo com metotrexato.	Iniciar 3 meses antes da conceção. Manter até ao fim do 1.o trimestre.
Niacina B3	16 mg/dia	10 mg/dia*	Rubor cutaneo, hepatotoxicidade. Interação com estatinas: risco de miopatia.	*UL aplica-se ao ac. nicotínico. Niacinamida tem perfil de segurança diferente.

5

MINERAIS

Iodo, Ferro, Cálcio, Magnésio, Zinco, Selénio

5.1 Iodo

Essencial para a síntese de T3 e T4. Janela terapêutica estreita: deficit e excesso causam disfunção tiroideia. Efeito de Wolff-Chaikoff: inibição da síntese hormonal por excesso de iodo. Fenomeno de Jod-Basedow: estimulação de tecido tiroideu autónomo com risco de hipertiroidismo, especialmente em idosos com nódulos subclínicos.

Situação	Conduta
Adulto saudável sem patologia tiroideia	Indicar até 150 mcg/dia. Dose máxima tolerável: 600 mcg/dia
Gravidez / amamentação	Necessidade 200-250 mcg/dia. Confirmar sempre com o médico assistente
Hipotiroidismo com levotiroxina	Referenciar ao médico. Pode alterar a dose necessária de levotiroxina
Hipertiroidismo / Graves / Hashimoto ativa	CONTRAINDICADO. Risco de crise tirotóxica ou exacerbação autoimune
Amiodarona	Interação grave. Amiodarona contem ~37% de iodo por peso
Idosos com nódulos tiroideus	Risco de Jod-Basedow. Não indicar sem avaliação médica
Algas marinhas (kelp, wakame, spirulina)	Teor imprevisível. Pode ultrapassar 600 mcg/dose. Desaconselhar sempre

5.2 Ferro

Situação	Conduta / Notas clínicas
Anemia ferropénica confirmada	Sulfato, gluconato ou bisglicinato ferrico. Tomar com vitamina C. Evitar chá, café, laticínios
Mulher em idade fértil com menorragia	Considerar suplementação preventiva. Avaliar sintomas de anemia
Hemocromatose	CONTRAINDICADO. Risco de sobrecarga de ferro com dano multiorgânico
DII ativa	Ferro oral pode agravar a inflamação. Referenciar para avaliação de ferro EV
Sem deficiência documentada	Não indicar. Excesso de ferro e pró-oxidante, associado a dano cardiovascular
Interações	Levotiroxina, quinolonas, tetraciclina, bifosfonatos: intervalo mínimo 2-4 horas

5.3 Cálcio

Situação	Notas clínicas
Dose de referência / UL	700-1000 mg/dia adultos. UL: 2500 mg/dia
Indicação válida	Osteoporose diagnosticada, pós-menopausa com ingestão insuficiente, malabsorção
Doses >1500 mg/dia	Associadas a maior risco cardiovascular. Preferir aporte dietético
Litíase renal / Hipercalcemia	Litíase: precaução. Hipercalcemia: CONTRAINDICADO
Interações	Levotiroxina, ferro, bifosfonatos, fluoroquinolonas: separar 2-4 horas
Com Vitamina D	Absorção de cálcio depende de níveis adequados de vitamina D. Associar se necessário

5.4 Magnésio

Situação	Notas clínicas
Dose ref. / UL suplementos	300-400 mg/dia. UL: 250 mg/dia
Oxido de magnésio	Biodisponibilidade baixa. Efeito laxante frequente. Não é a primeira escolha
Citrato / malato / bisglicinato	Melhor biodisponibilidade e tolerância GI. Formas preferidas
Doença renal crónica	Risco de hipermagnesemia. Contraindicado sem supervisão médica
Interações	Reduz absorção de levotiroxina, bifosfonatos, fluoroquinolonas, tetraciclina
Gravidez	Frequentemente indicado na prevenção de câibras. Dose segura até 350 mg/dia

5.5 Zinco

Situação	Notas clínicas
Dose ref.	8-11 mg/dia. UL: 25 mg/dia
Uso a curto prazo	Seguro até 25 mg/dia por 1-2 semanas. Indicado em suporte imunológico
Doses altas prolongadas	Deficit de cobre: anemia e neuropatia. Evitar >40 mg/dia por mais de 4 semanas
Interações	Reduz absorção de ferro não-heme, cobre, levotiroxina, quinolonas, tetraciclina
Dietas veganas	Biodisponibilidade reduzida por fitatos. Pode justificar dose ligeiramente superior

5.6 Selénio

Janela terapêutica estreita. Dose de referência: 55 mcg/dia. UL: 300 mcg/dia. Selenose crónica: queda de cabelo, fragilidade ungueal, neuropatia. Potencia a varfarina. Precaução em oncologia tiroideia (interfere com iodo radioativo). Não suplementar sem deficiência documentada.

6

ÁCIDOS GORDOS ESSENCIAIS

Omega-3: EPA e DHA

Aspeto / Condição	Notas clínicas
Dose habitual	250-500 mg EPA+DHA/dia prevenção. Até 2-3 g/dia em indicações específicas
Risco hemorrágico	Doses >3 g/dia aumentam tempo de sangria. Precaução em anticoagulados e antiplaquetários
Varfarina / NOAC	Potencia o efeito anticoagulante. Monitorizar INR se dose elevada
Gravidez e amamentação	DHA essencial para o desenvolvimento neurológico fetal. Seguro em doses habituais
Alergia ao peixe	Evitar oleos de peixe. Preferir omega-3 de algas (equivalente em DHA)
Diabetes tipo 2	Doses elevadas podem elevar ligeiramente a glicemia de jejum. Monitorizar
Qualidade	Verificar certificação IFOS. Risco de oxidação lipídica e contaminação por mercúrio em produtos de baixa qualidade

7

MULTIVITAMÍNICOS

Combinações e risco de acumulação

O multivitamínico não é neutro. Pode conter iodo, selénio, vitaminas A e D em percentagens elevadas do VRN. O risco de sobredosagem cumulativa com outros suplementos ou alimentos enriquecidos é real e frequentemente subestimado no balcão.

Ler sempre o rótulo completo com o utente. Confirmar teor de cada nutriente e % VRN. Valores >100% VRN em vitaminas A, D, B6, iodo ou selénio merecem atenção redobrada.

Avaliar a dieta habitual antes de indicar. Uma dieta equilibrada com peixe, laticínios e vegetais já fornece níveis elevados de vários nutrientes.

Identificar todos os suplementos em curso. Multivitamínico + vitamina D + magnésio + omega-3 é combinação frequente. Verificar sobreposição nutrientes.

Multivitamínicos prenatais já contêm iodo e folato. Nunca indicar suplemento adicional sem verificar se o pré-natal já os inclui nas doses adequadas.

Fórmulas para idosos podem ter níveis elevados de B12 e D. Avaliar medicação concomitante: anticoagulantes, antiepilépticos, levotiroxina.

Suplementos desportivos com vitaminas e minerais. Atletas tomam frequentemente proteínas, creatina e multivitamínico. Risco de duplicação elevado. Questionar sempre.

8

PLANTAS E FITOTERAPIA

Precauções específicas no balcão

Natural não é sinónimo de seguro. As plantas medicinais tem atividade farmacológica real. Muitas apresentam interações clinicamente significativas com medicamentos de uso comum e risco de hepatotoxicidade em doses elevadas ou uso prolongado.

Planta	Mecanismo e risco clínico	Conduta
Hipericao	Indutor potente CYP3A4 e P-gp. Reduz eficacia de antiretrovirais, ciclosporina, contraceptivos orais, digoxina, varfarina, ISRS. Risco de síndrome serotoninérgica.	Contraindicado com medicação crónica
Valeriana	Sedativo aditivo com benzodiazepinas, álcool e depressores do SNC. Pode prolongar anestesia.	Suspender 2 sem. pré-cirurgia
Ginkgo biloba	Inibe agregação plaquetária. Aumenta risco hemorrágico com anticoagulantes e AAS/clopidogrel.	Evitar em anticoagulados. Suspender pré-cirurgia
Alho concentrado	Efeito antiplaquetário. Potencia varfarina e anticoagulantes.	Precaução em anticoagulados
Equinacea	Imunoestimulante. Contraindicada em doenças autoimunes, transplantados, imunossuprimidos.	Max. 8 semanas continuas
Kava-kava	Hepatotoxicidade grave documentada. Proibido em vários países europeus.	CONTRAINDICADO
Cha verde extrato conc.	Hepatotoxicidade em doses elevadas de EGCG >800 mg/dia. Diferente do cha verde dietético.	Evitar extratos em dose alta
Efedra / Ma-huang	Estimulante cardiovascular grave: hipertensão, arritmias, AVC. Proibido na UE.	PROIBIDO na UE
Alcachofra / Cardo mariano	Alergia cruzada com Asteraceae. Precaução em colelitíase.	Precaução em colelitíase

9

POPULAÇÕES ESPECIAIS

Gravidez, Idosos, Crianças, Doença crónica

População	Consideracoes clínicas específicas
GRAVIDEZ	Indicar: ácido fólico 400-800 mcg, iodo 200 mcg, ferro se deficiente, DHA, vitamina D. Evitar: vitamina A >3000 UI/dia (teratogénica), megadoses, plantas medicinais. Verificar sempre se já toma multivitamínico pré-natal antes de indicar suplementos isolados.
AMAMENTAÇÃO	Necessidades aumentadas de iodo (250 mcg/dia) e DHA. A maioria dos nutrientes passa para o leite. Evitar plantas hepatotóxicas ou com atividade hormonal. Continuar vitamina D se bebe amamentado.
IDOSOS >65	Risco de deficiência de B12, D e cálcio. Polifarmácia aumenta risco de interações. Menor função renal: precaução com magnésio, selénio e iodo. Nódulos tiroideus subclínicos comuns: precaução com iodo (risco de Jod-Basedow). Vitamina K interfere com anticoagulantes frequentes nesta faixa etária.
CRIANÇAS	Não indicar sem indicação médica explícita. Doses para adultos são inadequadas pelo peso. Excecao: vitamina D nos primeiros meses de vida (recomendacao DGS). Ferro apenas com anemia documentada. Evitar plantas medicinais.
DOENÇA RENAL	Restrição de magnésio, potássio, fósforo e iodo. Risco de hipervitaminose D. Qualquer suplementação validada pelo nefrologista.
DOENÇA ONCOLÓGICA	Antioxidantes (C, E, selénio, beta-caroteno) podem reduzir eficacia de quimio/radioterapia. Suplementacao apenas com validacao oncológica. Folato contraindicado com metotrexato.
DOENÇAS AUTOIMUNES	Evitar imunoestimulantes (equinacea, astragalus). Vitamina D tem papel imunomodulador mas a dose deve ser monitorizada com o médico assistente.

10

MENSAGENS-CHAVE

Para a prática diária no balcão

1

Natural não é sinónimo de seguro.

Plantas, minerais e vitaminas em doses elevadas causam toxicidade real. A indicação farmacêutica exige o mesmo rigor que a dispensação de medicamentos.

2

Ler o rótulo e uma competência clínica.

Verificar o teor de cada nutriente, a forma química, os excipientes e a % VRN deve ser rotina antes de qualquer indicação.

3

A dieta vem antes do suplemento.

Avaliar se a necessidade nutricional pode ser suprida por ajuste alimentar. A suplementação é um complemento, não um substituto.

4

A duplicação é um risco real.

Multivitâmico + suplemento isolado + alimentos enriquecidos pode ultrapassar o UL de vários nutrientes. Questionar sempre o conjunto em uso.

5

As interações farmacológicas existem.

Hiperica, ginkgo, vitamina K, ferro, cálcio e magnésio interagem com medicamentos de uso comum. Verificar sempre antes de indicar.

6

Populações especiais exigem cautela acrescida.

Gravidez, idosos, doença renal, oncologia: contextos onde qualquer suplemento deve ser ponderado com maior rigor clínico.

7

O encaminhamento é uma indicação clínica.

Reconhecer os limites da indicação farmacêutica e parte integrante da competência do farmacêutico comunitário.

Sílvia Pernas | Farmacêutica Especialista em Farmácia Comunitária | NextPharma Academy

PharmaNotes | Suplementos Alimentares: Guia de Precauções para o Balcão de Farmácia